

1. Les acrosyndromes vasculaires sont toujours secondaires à une autre pathologie vasculaire.	1. Faux
2. Les acrosyndromes permanents sont caractérisés par des symptômes paroxystiques.	2. Faux
3. L'acrorhigose et l'acrocholose sont des acrosyndromes permanents.	3. Vrai
4. L'acrorhigose se manifeste par une sensation de chaleur permanente des extrémités.	4. Faux
5. L'acrocyanose est une manifestation indolore mais socialement invalidante des extrémités.	5. Vrai
6. La physiopathologie de l'acrocyanose implique une hypertonie sympathique et une stase capillaro-veinulaire.	6. Vrai
7. L'acrocyanose essentielle survient principalement chez les hommes de plus de 40 ans.	7. Faux
8. Le diagnostic de l'acrocyanose nécessite souvent des examens complémentaires comme la capillaroscopie.	8. Faux
9. Il n'existe aucun traitement médicamenteux susceptible améliorer l'acrocyanose.	9. Vrai
10. L'hyperhidrose est traitée avec des injections sous-cutanées de toxine botulinique en cas d'acrocyanose.	10. Vrai
11. Le syndrome des paumes rouges est également connu sous le nom de syndrome de Lane.	11. Vrai
12. Le syndrome des paumes rouges est souvent associé à une cirrhose du foie.	12. Faux
13. Le phénomène de Raynaud est le plus fréquent des acrosyndromes vasculaires.	13. Vrai

14. La prévalence globale des acrosyndromes vasculaires est d'au moins 10%.	14. Vrai
15. L'acrorhigose est parfois associée à des pathologies comme l'hyperthyroïdie.	15. Faux
16. Le phénomène de Raynaud est toujours associé à des troubles trophiques.	16. Faux
17. La connectivite est une étiologie possible du syndrome de Raynaud.	17. Vrai
18. Les bêtabloquants sont des médicaments souvent utilisés pour traiter le syndrome de Raynaud.	18. Faux
19. Les érythermalgies sont aggravées par l'exposition au froid.	19. Faux
20. L'acrocyanose est caractérisée par une cyanose et une froideur permanente des extrémités.	20. Vrai
21. La forme neurologique est la forme la plus fréquente du syndrome du défilé thoraco-brachial.	21. Vrai
22. Une anomalie d'insertion du muscle grand pectoral peut causer un syndrome du défilé thoraco-brachial.	22. Faux
23. Les symptômes du syndrome du défilé thoraco-brachial sont aggravés par l'effort physique.	23. Vrai
24. Les gelures touchent principalement les régions centrales du corps.	24. Faux
25. Les pré-gelures surviennent lorsque les fluides tissulaires gèlent.	25. Faux
26. Le traitement des gelures comprend un réchauffement rapide et des médicaments anti-inflammatoires.	26. Vrai
27. L'apoplexie digitale nécessite généralement un bilan et un traitement spécifique.	27. Faux
28. L'acrocyanose est une affection douloureuse.	28. Faux

29. Le livedo primaire apparaît et disparaît indépendamment de la température ambiante.	29. Vrai
30. Le traitement du syndrome de Raynaud est principalement chirurgical.	30. Faux
31. Les pré-gelures surviennent lorsque la température reste basse pendant plusieurs heures ou jours.	31. Vrai
32. Les gelures touchent principalement la partie distale des membres, le nez et les oreilles.	32. Vrai
33. Les gelures sont plus fréquentes chez les personnes sans abri.	33. Vrai
34. L'apoplexie digitale disparaît spontanément en quelques semaines.	34. Faux
35. L'acrorhigose se manifeste par une sensation de froid permanente et douloureuse des extrémités.	35. Faux
36. L'apoplexie digitale est caractérisée par une rupture brutale d'une artère digitale.	36. Faux
37. L'acrorhigose est plus fréquente chez les hommes jeunes.	37. Faux
38. Les acrosyndromes vasculaires désignent toute condition vasospastique ou obstructive qui induit des perturbations dans le réseau microvasculaire des extrémités.	38. Vrai
39. Les acrosyndromes vasculaires sont des pathologies extrêmement rares dans la population générale.	39. Faux
40. Le phénomène de Raynaud est rarement observé en consultation médicale.	40. Vrai
41. Les gelures peuvent souvent être confondues avec des mycoses.	41. Faux
42. L'acrocyanose est liée à une vasodilatation de la microvascularisation des extrémités.	42. Faux

43. L'acrorhigose est liée à une vasoconstriction de la microvascularisation des extrémités.	43. Vrai
44. Le livedo est liée à une vasodilatation de la microvascularisation des extrémités.	44. Faux
45. L'acrocholose est liée à une vasoconstriction de la microvascularisation des extrémités.	45. Faux
46. Les érythermalgies sont des acrosyndromes vasculaires paroxystiques.	46. Vrai
47. Le livedo est lié à une hyperhémie du réseau vasculaire du derme.	47. Faux
48. L'acrorhigose est plus fréquente chez la femme jeune.	48. Vrai
49. L'acrorhigose est un acrosyndrome vasculaire permanent lié à une hypertonie parasymphatique.	49. Faux
50. L'acrorhigose est une affection bénigne parfois associée à l'hypothyroïdie.	50. Vrai
51. Le phénomène de Raynaud primaire est généralement associé à des anomalies artérielles.	51. Faux
52. L'acrocyanose est caractérisée par une cyanose permanente des extrémités sans modification de température.	52. Faux
53. L'acrorhigose est souvent associée à une hyperhidrose de la paume des mains et de la sole plantaire.	53. Faux
54. Les érythermalgies peuvent révéler un syndrome myéloprolifératif.	54. Vrai
55. Les symptômes de l'acrocyanose sont accentués à l'exposition au froid.	55. Vrai
56. La plupart des cas d'acrocyanose sont secondaires à une pathologie hématologique (cryoglobulinémie, maladie des agglutinines froides, syndrome myéloprolifératif,...).	56. Faux

57. L'acrocyanose est essentielle dans la majorité des cas.	57. Vrai
58. L'acrocyanose est plus fréquente chez la femme de <30 ans et débute souvent à l'adolescence.	58. Vrai
59. L'acrocyanose est plus fréquente chez les sujets obèses.	59. Faux
60. L'acrocyanose se manifeste par des extrémités froides, bleues-violettes, oedémateuses et moites.	60. Vrai
61. Aucun examen complémentaires n'est habituellement requis pour diagnostiquer une acrocyanose.	61. Vrai
62. La capillaroscopie est un examen qui étudie les capillaires au niveau de la pulpe de l'index	62. Faux
63. L'arrêt du tabagisme et la prévention contre le froid sont nécessaires en cas d'acrocyanose.	63. Vrai
64. L'hyperhidrose peut être traitée par ionophorèse en cas d'acrocyanose.	64. Vrai
65. La sympathectomie endoscopique transthoracique est réservée aux cas d'hyperhidrose palmaire sévère et invalidante.	65. Vrai
66. Le livedo racemosa est une réaction physiologique à l'exposition au froid.	66. Faux
67. Le livedo est une érythrocyanose en réseau d'origine neurologique.	67. Faux
68. Le livedo reticularis montre un réseau complet en maille de filet et le livedo racemosa a un aspect ramifié.	68. Vrai
69. Le livedo est causée par une désoxygénation ou une stase sanguine des plexus dermiques sous-papillaires.	69. Vrai
70. Une augmentation du flux artériolaire dans le derme peut causer un livedo.	70. Faux

71. Une résistance augmentée au flux veineux (vasospasme, obstruction, hyperviscosité sanguine,...) dans le derme peut causer un livedo.	71. Vrai
72. Le livedo physiologique est plus fréquent chez les nouveau-nés et particulièrement chez les prématurés.	72. Vrai
73. Le livedo physiologique touche plus souvent des hommes âgés.	73. Faux
74. Le livedo primaire apparaît à l'exposition au froid et disparaît complètement au réchauffement.	74. Faux
75. Les érythermalgies sont améliorées par l'exposition au froid.	75. Vrai
76. Le livedo secondaire peut fluctuer selon l'âge chez les trisomiques (ou dans d'autres anomalies génétiques).	76. Vrai
77. Le cutis marmorata est caractérisé par une peau marbrée de façon pathologique.	77. Faux
78. Le livedo reticularis est très fréquent chez les femmes ou les jeunes filles à la peau claire.	78. Vrai
79. Le livedo idiopathique apparaît typiquement chez les hommes entre 20 et 60 ans.	79. Faux
80. Il existe un traitement spécifique pour le livedo.	80. Faux
81. Le livedo primaire est un diagnostic d'exclusion en l'absence de pathologie sous-jacente.	81. Vrai
82. Le livedo idiopathique se manifeste par une marbrure paroxystique de la peau.	82. Faux
83. Le livedo reticularis persiste après le réchauffement.	83. Faux
84. Les ramifications du livedo racemosa sont souvent le signe d'une pathologie sous-jacente.	84. Vrai

85. Le livedo secondaire apparait à l'exposition au froid et disparaît complètement au réchauffement.	85. Faux
86. Les vascularites leucoplasiques, la périarthrite noueuse, les cryoglobulinémies, les embolies de cholestérol, les syndromes myéloprolifératifs et les artériopathies oblitérantes sont des causes de livedo secondaire.	86. Vrai
87. Les infections ne sont jamais associées au livedo racemosa.	87. Faux
88. Les anticorps antiphospholipides ou la CIVD sont des causes de livedo reticularis.	88. Faux
89. L'acrocholose est l'affection inverse de l'acrocyanose.	89. Faux
90. L'acrocholose est une affection bénigne parfois associée à l'hypothyroïdie.	90. Faux
91. L'acrocholose se manifeste par une sensation de chaleur et de brûlure permanente des extrémités.	91. Vrai
92. Il faut exclure une neuropathie périphérique sous-jacente avant de poser le diagnostic d'acrocholose.	92. Vrai
93. L'acrocholose et l'acrorhigose sont des sensations subjectives de la température des extrémités sans objectivation clinique.	93. Vrai
94. Le syndrome des paumes rouges est causé par une anomalie microcirculatoire constitutionnelle.	94. Vrai
95. Les capillaires sous-cutanés sont disposés perpendiculairement à la peau au niveau des mains en cas de syndrome de Lane.	95. Faux
96. Le syndrome de Lane est caractérisé par un tableau d'érythème palmaire permanent.	96. Vrai

97. Un érythème palmaire acquis peut survenir durant la grossesse.	97. Vrai
98. Le syndrome de Raynaud est caractérisée par une coloration bleue puis blanche puis rouge des extrémités.	98. Faux
99. La phase syncopale du phénomène de Raynaud est caractérisée par un blanchissement proximal des doigts (et/ou des orteils) qui deviennent insensibles.	99. Faux
100. La phase asphyxique du phénomène de Raynaud se caractérise par une cyanose bleutée des doigts.	100. Vrai
101. La phase hyperhémique est la première phase du phénomène de Raynaud.	101. Faux
102. La phase hyperhémique du phénomène de Raynaud est caractérisée par une érythrose douloureuse.	102. Vrai
103. Le phénomène de Raynaud est dû à une vasomotricité augmentée distale d'origine orthosympathique.	103. Vrai
104. Le phénomène de Raynaud secondaire est appelée maladie de Raynaud.	104. Faux
105. Le syndrome de Raynaud peut être le signe d'une pathologie grave.	105. Vrai
106. La phénomène de Raynaud primaire est une maladie tout à fait bénigne.	106. Vrai
107. Le syndrome de Raynaud touche 4 fois plus souvent les femmes que les hommes.	107. Faux
108. La maladie de Raynaud débute souvent avant 40 ans.	108. Vrai
109. Le syndrome de Raynaud atteint rarement les pouces.	109. Faux
110. La présentation du syndrome de Raynaud est le plus souvent bilatérale.	110. Faux

111. Les anomalies artérielles sont toujours absentes en cas de maladie de Raynaud.	111. Vrai
112. Les troubles trophiques sont rarissimes en cas de syndrome de Raynaud.	112. Faux
113. La capillaroscopie est parfois anormale en cas de maladie de Raynaud.	113. Faux
114. Le pronostic de la maladie de Raynaud est excellent.	114. Vrai
115. Le syndrome de Raynaud peut débuter à tout âge.	115. Vrai
116. Les analyses de laboratoire ne sont jamais anormales en cas de phénomène de Raynaud.	116. Faux
117. La maladie de Raynaud touche autant les hommes que les femmes.	117. Faux
118. La maladie de Raynaud touche 2 fois plus souvent les femmes que les hommes.	118. Faux
119. La sclérodermie est fréquemment associée à un phénomène de Raynaud.	119. Vrai
120. Le lupus, la polyarthrite rhumatoïde, le syndrome de Sjogren et la dermatomyosite sont plus souvent associés au phénomène de Raynaud que la sclérodermie.	120. Faux
121. La forme CREST de la sclérodermie est associée à des troubles de la motilité intestinale.	121. Faux
122. La forme CREST de la sclérodermie est associée au phénomène de Raynaud dans >90% des cas.	122. Vrai
123. La forme CREST de la sclérodermie est associée à des calcifications sous-cutanées, des télangiectasies et une sclérodactylie.	123. Vrai

124. Les téléangiectasies sont des taches cutanées qui ne disparaissent pas à la vitropression.	124. Faux
125. La forme CREST du lupus associe des calcifications sous-cutanées, un Raynaud, des troubles de la motilité œsophagienne, une sclérodactylie et des téléangiectasies.	125. Faux
126. La phénomène de Raynaud peut être associée à la maladie de Buerger ou à des embolies.	126. Vrai
127. Les bêta-bloquants sont recommandés dans le traitement du phénomène de Raynaud.	127. Faux
128. Le syndrome du défilé thoraco-brachial est une cause de phénomène de Raynaud.	128. Vrai
129. La compression neurologique du syndrome du canal carpien peut provoquer un phénomène de Raynaud.	129. Vrai
130. Il n'existe aucun traitement médicamenteux susceptible d'améliorer le phénomène de Raynaud.	130. Faux
131. Des microtraumatismes répétés et des vibrations peuvent engendrer un phénomène de Raynaud.	131. Vrai
132. Les chocs répétés sur le poignet peuvent engendrer un anévrisme cubital emboligène et un phénomène de Raynaud chez les joueurs de volley-ball.	132. Vrai
133. Les dérivés de l'ergot et certains promitotiques peuvent provoquer un phénomène de Raynaud.	133. Faux
134. Les bêta-bloquants sont les médicaments les plus souvent incriminés dans la genèse ou l'exacerbation d'un phénomène de Raynaud.	134. Vrai
135. L'arrêt du tabac et la protection contre le froid sont recommandés en cas de phénomène de Raynaud.	135. Vrai

136. Les autres connectivites sont moins souvent associés au phénomène de Raynaud que la sclérodermie.	136. Vrai
137. Certaines maladies hématologiques provoquent un phénomène de Raynaud : agglutinines chaudes, cryofibrinogénémie, cryoglobulinémie,...	137. Faux
138. Les antagonistes calciques comme le diltiazem sont utilisés dans le phénomène de Raynaud.	138. Faux
139. Les antagonistes calciques entraînent de nombreux effets secondaires : bouffées de chaleur, œdème des membres inférieurs, céphalées,...	139. Vrai
140. La nifédipine est utilisée dans le traitement du phénomène de Raynaud en cas d'invalidité importante.	140. Vrai
141. Les érythermalgies sont l'affection inverse du phénomène de Raynaud.	141. Vrai
142. Les érythermalgies sont soulagées par la position déclive (au coucher).	142. Faux
143. Les érythermalgies sont caractérisées par des douleurs de type brulure et un érythème des extrémités provoqués par la chaleur.	143. Vrai
144. Les symptômes des érythermalgies sont présents en permanence.	144. Faux
145. Les symptômes des érythermalgies sont soulagées au froid ou en surélevant la partie atteinte.	145. Vrai
146. Les érythermalgies sont surement liées à des troubles de la coagulation et de l'agrégation plaquettaire.	146. Faux
147. Des troubles du métabolisme des prostaglandines sont responsables d'érythermalgies.	147. Vrai

148. Les érythermalgies ne sont jamais idiopathiques.	148. Faux
149. Le syndrome du défilé thoraco-brachial est très fréquent chez les adultes.	149. Faux
150. Le syndrome du défilé thoraco-brachial regroupe toutes les manifestations cliniques liées à la compression intermittente ou permanente du plexus brachial ou de l'artère et la veine sous-clavière.	150. Vrai
151. Une méga-apophyse transverse de Th2 peut causer un syndrome du défilé thoraco-brachial.	151. Faux
152. La compression s'exerce parfois entre le muscle sous-clavier et la 1 ^{ère} côte (pince costo-claviculaire) dans le syndrome du défilé thoraco-brachial.	152. Vrai
153. Un cal osseux post-fracture de la clavicule provoque souvent un syndrome du défilé thoraco-brachial.	153. Vrai
154. La côte cervicale est une cause acquise de syndrome du défilé thoraco-brachial.	154. Faux
155. La compression s'exerce dans un espace qui s'étend du défilé interscalénique au tunnel sous-pectoral en cas de syndrome du défilé thoraco-brachial.	155. Vrai
156. Les épaules tombantes sont une cause fonctionnelle de syndrome du défilé thoraco-brachial.	156. Vrai
157. Une faiblesse musculaire loco-régionale ne cause jamais un syndrome du défilé thoraco-brachial.	157. Faux
158. Tous les déséquilibres fonctionnels de la région cervico-scapulaire peuvent provoquer un syndrome du défilé thoraco-brachial.	158. Vrai

159. Les symptômes du syndrome du défilé thoraco-brachial ne sont jamais présents au repos.	159. Faux
160. Un phénomène de Raynaud bilatéral peut être la conséquence d'un syndrome du défilé thoraco-brachial.	160. Faux
161. Les compressions vasculaires sont plus fréquentes que la compression neurologique en cas de syndrome du défilé thoraco-brachial.	161. Faux
162. Les symptômes du syndrome du défilé thoraco-brachial sont provoqués ou aggravés par l'effort.	162. Vrai
163. La surélévation prolongée ou répétée du membre inférieur peut provoquer des symptômes d'un syndrome du défilé thoraco-brachial.	163. Faux
164. Le syndrome du défilé thoraco-brachial ne provoque jamais d'ischémie des doigts.	164. Faux
165. La compression artérielle peut provoquer une thrombose ou un anévrisme emboligène de l'artère axillaire en cas de syndrome du défilé thoraco-brachial.	165. Faux
166. La claudication intermittente du bras peut être la conséquence d'un syndrome du défilé thoraco-brachial.	166. Vrai
167. Une phlébite d'effort peut survenir dans le bras suite à la compression artérielle en cas de syndrome du défilé thoraco-brachial.	167. Faux
168. La compression veineuse provoque un œdème de la main en cas de syndrome du défilé thoraco-brachial.	168. Vrai
169. Le syndrome du défilé thoraco-brachial peut causer une faiblesse ou une fatigue positionnelle du MS.	169. Vrai

170. Les paresthésies surviennent dans le territoire de C7 en cas de syndrome du défilé thoraco-brachial.	170. Faux
171. La douleur est le signe le plus fréquent du syndrome du défilé thoraco-brachial quelle qu'en soit la cause.	171. Vrai
172. La compression neurologique peut entrainer une hypoesthésie et une atrophie des muscles de la main en cas de syndrome du défilé thoraco-brachial.	172. Vrai
173. L'examineur explore surtout l'axe veineux lors des manœuvres dynamiques pour diagnostiquer un syndrome du défilé thoraco-brachial.	173. Faux
174. La manœuvre d'hyperabduction est le meilleur moyen de repérer un syndrome du défilé thoraco-brachial.	174. Faux
175. L'apparition d'un souffle sus-claviculaire lors du mouvement permet de diagnostiquer un syndrome du défilé thoraco-brachial.	175. Vrai
176. La chirurgie est le traitement de choix pour le syndrome du défilé thoraco-brachial.	176. Faux
177. La disparition du pouls ulnaire lors du mouvement permet de diagnostiquer un syndrome du défilé thoraco-brachial.	177. Faux
178. Le traitement du syndrome du défilé thoraco-brachial repose sur une rééducation adaptée.	178. Vrai
179. La manœuvre d'hyperabduction fait souvent disparaître le pouls radial même chez le sujet sain.	179. Vrai
180. Il faut éviter le port de charges lourdes en cas de syndrome du défilé thoraco-brachial.	180. Vrai

181. La manœuvre d'Adson consiste en une position de garde-à-vous exagérée en inspiration profonde pour diagnostiquer un syndrome du défilé thoraco-brachial.	181. Faux
182. Les engelures font partie des acrosyndromes vasculaires.	182. Faux
183. Les engelures surviennent à la fin de l'automne et en hiver (saisons froides et humides).	183. Faux
184. Les engelures sont des lésions cutanées inflammatoires liées au froid et à l'humidité.	184. Vrai
185. Les engelures consistent en une vraie congélation tissulaire.	185. Faux
186. Les engelures surviennent uniquement en hiver lorsqu'il gèle.	186. Faux
187. Les engelures sont des lésions bénignes et fréquentes à caractère saisonnier.	187. Vrai
188. Les engelures sont favorisées par un terrain familial, l'acrorhigose et un phénomène de Raynaud.	188. Faux
189. L'engelure est une plaque ou une papule oedémateuse, prurigineuse, algique et érythrocyanotique.	189. Vrai
190. Les engelures peuvent survenir sur n'importe quelle partie du corps.	190. Vrai
191. Les engelures sont des lésions douloureuses qui grattent beaucoup.	191. Vrai
192. Les engelures n'évoluent jamais vers une ulcération (aspect de trouble trophique ischémique).	192. Faux
193. Les engelures sont plus fréquentes chez les jeunes hommes avec un BMI bas.	193. Faux
194. L'évolution des engelures se fait par poussées de 2 à 4 semaines.	194. Vrai

195. Les engelures évoluent vers une guérison spontanée progressive et généralement ne récidivent pas.	195. Faux
196. Il n'existe pas de traitement vraiment efficace contre les engelures.	196. Vrai
197. Les vasoconstricteurs et les antagonistes calciques peuvent être utiles dans le traitement des engelures.	197. Faux
198. Les engelures récidivantes ont généralement un mauvais pronostic.	198. Faux
199. Les gelures sont caractérisées par la formation de cristaux de glace dans les tissus superficiels et profonds.	199. Vrai
200. Les gelures sont rares en Belgique.	200. Vrai
201. Les pré-gelures surviennent souvent quand la température reste à -0,5°C pendant plusieurs heures.	201. Vrai
202. Le réchauffement des pré-gelures provoquent des signes de neuropathies sensitives localisées.	202. Vrai
203. Les pré-gelures sont diagnostiquées sur base de signes objectifs.	203. Faux
204. L'exposition prolongée au froid et à l'humidité sans possibilité de se sécher correctement augmente le risque de pré-gelures.	204. Vrai
205. L'aspirine et l'ibuprofène sont utilisés dans le traitement des gelures.	205. Vrai
206. Un réchauffement rapide est nécessaire pour traiter les pré-gelures.	206. Faux
207. L'apoplexie digitale est caractérisée par un hématome digital spontanée par rupture d'une veine.	207. Vrai
208. L'apoplexie digitale est un processus très douloureux de début progressif.	208. Faux